

【经验交流】

神经肌肉电刺激对顺产后子宫复旧进程及 产后出血的影响

章青英

(清远市中医医院产科, 广东 清远 511500)

【摘要】 目的:探讨神经肌肉电刺激对顺产后子宫复旧和产后出血的影响。**方法:**选择200例足月阴道分娩的产妇为研究对象,采取随机排列法将其分成对照组和观察组各100例。对照组产妇分娩后予以基础护理及喂养指导,观察组在对照组基础上予以神经肌肉电刺激治疗,比较两组子宫复旧、产后出血情况及机体恢复情况。**结果:**观察组产后24h恶露量高于对照组,子宫体积小于对照组,差异均有统计学意义($P<0.05$);两组宫底高度比较,差异无统计学意义($P>0.05$);观察组产后出血量少于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$);观察组泌乳时间及开始活动时间均早于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)。**结论:**顺产后子宫复旧和预防产后出血采用神经肌肉电刺激治疗可促进子宫恢复,降低产后出血量,有利于产妇机体康复,可在临床广泛推广使用。

【关键词】 产后出血; 子宫复旧; 顺产; 神经肌肉电刺激

doi: 10.3969/j.issn.1672-0369.2019.23.045

中图分类号: R714.6

文献标识码: B

文章编号: 1672-0369(2019)23-0113-03

Effects of neuromuscular electrical stimulation on uterine involution process and postpartum hemorrhage after spontaneous delivery

ZHANG Qingying

(Department of Obstetrics of Qingyuan Hospital of Traditional Chinese Medicine, Qingyuan 511500 Guangdong, China)

【Abstract】 Objective: To analyze effects of neuromuscular electrical stimulation on uterine involution process and postpartum hemorrhage after spontaneous delivery. **Methods:** 200 full-term puerperae underwent vaginal delivery were selected as the subjects and divided into control group ($n=100$) and observation group ($n=100$) according to the random number table method. The control group was given basic nursing and feeding guidance, while the observation group was given neuromuscular electrical stimulation treatment based on the basic nursing and feeding guidance. The uterine involution, postpartum hemorrhage, and body recovery were compared between the two groups. **Results:** 24h after the delivery, the lochia volume in the observation group was higher than that of the control group; the uterine volume was smaller than that of the control group; and the differences were statistically significant ($P<0.05$). There was no significant difference in the fundus height between the two groups ($P>0.05$). The amount of postpartum hemorrhage in the observation group was less than that in the control group, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). The lactation time and start time of activity in the observation group were shorter than those in the control group, and the differences were statistically significant ($P<0.05$). **Conclusions:** The neuromuscular electrical stimulation can promote the uterine function recovery, reduce the postpartum bleeding volume and promote the physical recovery. Therefore, it shall be widely applied in the clinical practice.

【Key words】 Postpartum hemorrhage; Uterine involution; Spontaneous delivery; Neuromuscular electrical stimulation

妊娠分娩是育龄期女性人生一个重要时期,其中从胎盘娩出后子宫开始恢复至妊娠前状态称为子宫复旧,通常情况下产妇产后10天左右恢复至原来状态^[1]。若子宫在分娩后无法顺利收缩称为子宫复旧不全,子宫复旧情况直接影响产妇机体恢复,若产妇分娩后子宫复旧不全,极易引发产后出血等一系列严重并发症,危害产妇生命安全^[2]。因此采取积极有效的措施促进产妇产后复旧对预防产后出血有积极意义。本文观察神经肌肉电刺激对顺产后子宫复旧进程及产后出血的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年1月至2019年6月

作者简介: 章青英(1968.04-),女,本科,副主任医师,研究方向:妇产科,电话:15813239806。

清远市中医医院产科实施足月阴道分娩的200例产妇为研究对象。纳入标准:均为顺产;足月分娩。孕妇对本次研究知情,并签署知情同意书。采取随机排列法分成观察组和对照组各100例。对照组:年龄26~32岁;平均(29.86 ± 3.55)岁;妊娠周期38~42周,平均(39.58 ± 1.53)周;观察组:年龄27~32岁;平均(30.04 ± 3.62)岁;妊娠周期38~42周,平均(39.26 ± 1.50)周。两组一般资料比较,差异无统计学意义($P>0.05$),有可比性。
1.2 方法 对照组产妇予以基础护理及喂养指导,分娩后指导产妇与新生儿早期接触,对其实施母乳喂养知识宣教,密切关注产妇生命体征变化情况以及产后出血情况。观察组在对照组基础上联合神经肌肉电刺激治疗,分娩后,实施基础护理,并于产

后 30 min 内实施母婴早期接触,随后使用低频神经肌肉治疗仪实施治疗:嘱产妇平卧于治疗床上,分别于产妇子宫体表投影位置以及骶尾部放置电极片,前后各两片,电极片距离为 12 cm,予以妥善固定。随后打开机器并选择子宫复旧模式,电流强度由 0 mA 开始逐步增大,电刺激强度应以产妇有脉搏搏动感为最佳,通常在 8.0~18.0 mA 之间,每天治疗 1 次,每次 24 min,持续治疗至出院。

1.3 观察指标 (1) 比较两组产妇子宫复旧情况,包括产后 24 h 恶露量以及宫底高度、产后 42 d 子宫体积;(2) 比较两组产后出血情况;(3) 比较两组机体恢复情况,包括泌乳时间和开始活动时间。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 18.0 软件进行数据处理,计量资料以 $(\bar{x} \pm s)$ 表示,比较采用 t 检验,以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组产妇子宫复旧情况比较 观察组产后 24 h 恶露量高于对照组,子宫体积小于对照组,差异均有统计学意义 ($P < 0.05$); 两组宫底高度比较,差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。见表 1。

表 1 两组产妇子宫复旧情况比较 ($\bar{x} \pm s$)

分组	恶露量 (mL)	宫底高度 (cm)	子宫体积 (cm)
对照组 ($n=100$)	186.74 $\pm$ 47.06	27.21 $\pm$ 6.49	18.26 $\pm$ 2.84
观察组 ($n=100$)	225.36 $\pm$ 52.79	27.11 $\pm$ 6.94	15.49 $\pm$ 2.26
t 值	5.461	0.105	7.632
P 值	0.000	0.916	0.000

2.2 两组产后出血情况比较 观察组产后出血量少于对照组,差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 2。

表 2 两组产后出血情况比较 (mL, $\bar{x} \pm s$)

分组	出血量
对照组 ($n=100$)	347.76 $\pm$ 33.42
观察组 ($n=100$)	254.56 $\pm$ 30.16
t 值	20.703
P 值	0.000

2.3 两组机体恢复情况比较 观察组泌乳时间及开始活动时间均早于对照组,差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 3。

表 3 两组机体恢复情况比较 (h, $\bar{x} \pm s$)

分组	泌乳时间	开始活动时间
对照组 ($n=100$)	35.11 $\pm$ 4.79	41.44 $\pm$ 4.84
观察组 ($n=100$)	25.39 $\pm$ 2.03	34.19 $\pm$ 3.56
t 值	18.684	12.067
P 值	0.000	0.000

3 讨论

产妇产后通常于分娩后 10 d 左右会逐渐恢复至未孕前状态,一般需 4 周至 6 周时间才能完全恢复^[3]。若产妇在分娩后子宫体积增大,并且排出大量血性恶露,同时伴有腹痛等症状时,通常为子宫复旧不全^[4]。导致子宫复旧不全的因素包括子宫肌瘤、胎盘滞留、胎膜早破及多胎妊娠等^[5]。若产妇发生子宫复旧不全,会导致子宫腔内产生大量凝固血块,加之产妇产褥期机体抵抗力下降,若出现逆行感染,极易加重子宫收缩乏力程度,出现产后出血等情况,严重威胁产妇生命安全,因此产后对产妇子宫复旧情况实施密切关注尤为重要^[6]。

传统促进子宫复旧的方法为宫底按摩,但该种方式在临床长期应用中逐渐暴露弊端,其会导致产妇产褥期恶露情况加重,给产妇带来较大痛苦^[7-9]。林蓓蓓等^[10]研究认为,使用生物反馈电刺激与盆底肌锻炼可有效促进产妇盆底肌功能及盆底组织器官功能恢复。本研究结果显示,治疗后观察组产后 24 h 恶露量高于对照组,子宫体积小于对照组,观察组产后出血量少于对照组,原因可能是使用电刺激可促进产妇局部组织血液循环,并且可一定程度上刺激盆底肌功能恢复,增强其收缩功能,进而促进子宫正常收缩,有利于子宫尽快排出淤血。本研究结果还显示,观察组产妇泌乳时间、以及开始活动时间均早于对照组,原因可能是产妇产后子宫复旧情况良好,有利于其机体康复,加之母婴早期接触可促进产妇泌乳功能,改善其胃肠道功能,产妇生命质量明显提高。

综上所述,顺产后子宫复旧和预防产后出血采用神经肌肉电刺激可改善产妇子宫复旧情况,减少产后出血量,促进产妇机体早日康复,值得在临床广泛推广。

参考文献

- [1] 陈继龙, 冯筠. 骨髓间充质干细胞移植联合生化止血方治疗产后子宫复旧不全 [J]. 中国组织工程研究, 2017, 21 (21): 3346-3351.
- [2] 翟瑶. 缩宫素联合养血复宫方用于产后子宫复旧不全疗效观察 [J]. 现代中西医结合杂志, 2016, 25 (20): 2240-2242.
- [3] 时惠霞, 丁亚艳, 李晓敏, 等. 产后康复操对产妇子宫复旧、肌肉恢复及恶露排出的影响 [J]. 齐鲁护理杂志, 2016, 22 (18): 84-85.
- [4] 郭静, 王建军, 童晓文, 等. 缩宫素联合鲜益母草胶囊及缩宫素联合五加生化胶囊治疗产后子宫复旧不良的临床疗效比较 [J]. 中国性科学, 2018, 27 (6): 124-127.
- [5] 冯丽霞. 补气化瘀方治疗气虚血瘀型剖宫产后子宫复旧不全

- 恶露不绝临床观察[J]. 陕西中医, 2017, 38(5): 621-622.
- [6] 袁亚楠, 聂金霞, 陈难, 等. 桂枝茯苓汤化裁联合缩宫素对于子宫复旧不全并恶露不尽的疗效观察[J]. 中国合理用药探索, 2019, 16(1): 123-127.
- [7] 黄小红, 潘伙燕, 叶燕美, 等. 产后治疗仪联合乳房穴位按摩对促进产妇乳汁分泌及子宫复旧的影响[J]. 护理实践与研究, 2017, 14(10): 64-65.
- [8] 时惠霞, 丁亚艳, 李晓敏, 等. 产后康复操对产妇产后子宫复旧、肌肉恢复及恶露排出的影响[J]. 齐鲁护理杂志, 2016, 22(18):

84-85.

- [9] 陈青青, 陈珊珊, 周燕, 等. 催产素不同剂量及给药方式对自然分娩产妇产后子宫复旧效果影响的比较[J]. 护理与康复, 2017, 16(4): 341-343.
- [10] 林蓓蓓, 祖月娥, 范幸, 等. 仿生物电刺激联合生物反馈治疗女性产后性功能障碍的疗效分析[J]. 中国性科学, 2016, 25(3): 62-64.

编辑: 崔丽君

(上接第106页)

高^[5]。采取系统、规范的岗位培训提高手术室低年资护士应急协调能力对保证患者安全、促进医护配合度、提高手术护理质量的意义重大。

本研究结果显示, 观察组工作能力自我评价评分、急救知识、急救技术操作、急救仪器使用考核成绩均高于对照组, 这一结果与文献报道相吻合^[6-7]。此次培训针对低年资护士存在的手术配合不熟练、急重症抢救缺乏条理性、理论知识不足、协调沟通能力较差等缺陷制定培训方案, 由资深护士带教低年资护士并进行定期考核了解培训效果, 完善的考核评估体系有助于其提升急救水平, 发现自身存在不足之处及时改进, 培训结合考核促使低年资护士应急能力显著提升。同时低年资护士通过学习积累、熟练掌握各种急救知识、急救措施可提高自身应急协调能力, 而资深护士在培训中起到示范、引导和监督的作用, 促进手术室整体工作水平提升。所以低年资护士经过一系列科学、合理的培训后, 低年资护士的工作能力和专业知识、急救技术均有明显提升。本研究结果还显示, 低年资护士培训后手术配合质量、突发事件处理能力、协调沟通能力、安全管理能力、服务态度评分均明显高于培训前, 这一结果与文献报道相吻合^[7]。分析原因是通过专业知识、急救技能培训及模拟突发事件探讨应急处理方案提高低年资护士突发事件处理能力、安全管理能力, 通过跟随资深护士手术配合积累经验、向手术医师学习术中配合要点提高其手术配合质量, 通过学习协调沟通技巧提高其服务态度, 通过考核、记笔记方式不断强化培训成果使低年资护士岗位胜任能力逐步提升。同时本研究结果显示, 培训后低年资护士护理差错发生率明显低于培训前, 这一结果与文献报道相吻合^[9]。经验不足、责任心欠缺、急救技术不熟练、护理操作不规范是造成低年资护士发生护理差错事

件的主要原因, 注重护士专业知识、手术配合、急救技术培训对减少护理差错非常重要^[10]。此次培训通过专业知识、急救技能、手术配合、应急能力、协调沟通能力5个方面全方位的培训使低年资护士整体水平提升、更加注重工作细节, 有效防止护理差错出现。

综上所述, 应急协调能力培训应用可明显提高低年资护士的工作能力及应急协调能力, 减少护理差错。

参考文献

- [1] 林素羽, 符琼燕, 陈叶丹, 等. 手术室护理干预在预防胃肠道手术患者切口感染的临床效果分析[J]. 中华医院感染学杂志, 2016, 26(5): 1179-1180.
- [2] 刘珂欣, 衡春妮, 郭晓岚, 等. 低年资护士临床核心能力评价指标研究[J]. 现代预防医学, 2016, 43(10): 1917-1920.
- [3] 敬洁, 顾凤娇, 王帆, 等. 跨专业合作情景模拟教学在手术室低年资护士岗位培训中的应用与效果评价[J]. 中国组织工程研究, 2016, 20(b05): 179-181.
- [4] 吴赞芳, 吴芳琴, 吴静静, 等. 群体突发事件模拟演练提高急诊护士综合应急能力的效果评价[J]. 中国急救复苏与灾害医学杂志, 2016, 11(11): 1108-1110.
- [5] 余本敏, 黄攀, 潘晶晶, 等. 某三级甲等妇幼保健院122例护理不良事件分析及对策[J]. 中华现代护理杂志, 2016, 22(14): 1971-1974.
- [6] 郑敏, 龚静, 毕科, 等. 急诊6大病种情景演练培训模式对低年资护士的培训效果研究[J]. 重庆医学, 2016, 45(20): 2763-2764.
- [7] 彭莉, 夏黎明, 朱文珍, 等. PDCA+情景模拟教学在放射科低年资护士与技术员急救培训中的应用[J]. 放射学实践, 2016, 31(9): 890-892.
- [8] 陈晨, 黎丽, 孙宇佳, 等. CDIO带教模式在手术室新护士规范化培训中的应用和对护士核心能力影响研究[J]. 中国地方病防治杂志, 2017, 32(10): 1144-1146.
- [9] 周亚芬, 胡文娟, 杨霞, 等. 手术室青年护士专业核心能力的培养与实践[J]. 中华护理杂志, 2016, 51(5): 604-608.
- [10] 张岚, 张苏娟, 高萍, 等. 前馈控制在手术室护理安全管理中的应用效果[J]. 中国医药导报, 2016, 13(14): 154-157.

编辑: 王歌